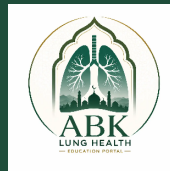


Peak Flow Meter

A practical guide for monitoring asthma



PEAK EXPIRATORY FLOW (PEF)

Measure • Record • Recognize • Change

Why use a peak flow meter?

PEF is a simple measure of how fast you can blow air out of your lungs. When your clinician asks you to monitor it, regular readings can help identify changes in airflow and support asthma assessment and self-management.

How to measure your PEF

1	Choose the same position each time — standing or sitting upright — and keep it consistent.
2	Move the marker/pointer back to the starting position. Hold the meter so your fingers do not block the scale.
3	Take a deep breath in and fill your lungs as much as you comfortably can.
4	Place the mouthpiece in your mouth and make a tight seal with your lips.
5	Blow out ONCE — as hard and as fast as you can. Do not blow slowly.
6	Note the reading. Reset the marker and repeat the test two more times.
7	Record ONLY the highest of the three readings.

When should I measure?

- If your clinician has asked you to monitor PEF, a common approach is morning and evening for 1–2 weeks using the SAME meter.
- Follow the timing given by your clinician, especially in relation to your inhalers.
- Record symptoms or reliever use when your clinician has asked you to do so.

Important points

- Use the same peak flow meter for your serial readings.
- Technique matters: a poor seal, slow blow, cough, or blocked mouthpiece can give a misleading result.
- PEF is less reliable than spirometry and should not be used by itself to diagnose asthma.
- Do not stop, increase, or decrease asthma medicines based only on a PEF number unless your clinician has given you a written action plan.

If you are very unwell

Do not delay urgent medical care to measure peak flow. Severe breathlessness, difficulty speaking, blue/grey lips, drowsiness/confusion, or rapidly worsening symptoms require urgent assessment.

Learn more about asthma and respiratory health

Scan the QR code to visit the ABK Lung Health Education Portal.

abdullah-bin-khurram.github.io/blogs/



Patient: _____

Personal Best PEF: _____ L/min

Date: _____

پیک فلو میٹر

دمہ کی نگرانی کے لیے آسان رہنما



عروجی اخراجی بہاؤ (PEF)

پیمائش کریں • درج کریں • تبدیلی کو پہچانیں

پیک فلو میٹر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو عروجی اخراجی بہاؤ (PEF) کی نگرانی کا مشورہ دیں تو کو باقاعدہ پیمائش سانس کی نالیوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے اور دمہ کو قابو رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔

PEF ناپنے کا درست طریقہ

1	ہر بار ایک ہی بنیٹ اختیار کریں — سیدھے کھڑے ہو کر یا سیدھے بیٹھ کر — اور اسے مستقل رکھیں۔
2	آلے کے نشان (پوائنٹر) کو ابتدائیہ (صفر) پر واپس لائیں۔ آلے کو اس طرح پکڑیں کہ انگلیاں پیمانے کو نہ ڈھانپیں۔
3	گہرا سانس اندر لیں اور جتنا آرام سے ممکن ہو پھیپھڑوں کو بھر لیں۔
4	آلے کے متعلقہ سرے کو منہ میں رکھیں اور ہونٹوں سے اس کے گرد مضبوطی سے بند کریں۔
5	ایک ہی بار میں پوری طاقت اور جتنی تیزی سے ممکن ہو سانس باہر نکالیں۔ آہستہ آہستہ نہ پھونکیں۔
6	پیمائش دیکھیں۔ نشان کو دوبارہ ابتدائی پوزیشن پر لائیں اور مزید دو مرتبہ پیمائش کریں۔
7	تینوں پیمائشوں میں سے صرف سب سے زیادہ پیمائش کا اندراج کریں۔

اخراجی بہاؤ کب ناپنا ہے؟

- اگر ڈاکٹر نے اخراجی بہاؤ کی نگرانی کا مشورہ دیا ہو تو ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی آلہ استعمال کرتے ہوئے 1-2 ہفتوں تک صبح اور شام پیمائش کی جائے۔
- اپنے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ترتیب اور وقت پر عمل کریں، خاص طور پر منشقہ (انہیلر) کے استعمال کے حوالے سے۔
- اگر ڈاکٹر نے کہا ہو تو علامات یا فوری قابو کرنے والے منشقہ (Reliever) کے استعمال کو بھی ساتھ درج کریں۔

اہم باتیں

- مسلسل پیمائش کے لیے ہمیشہ ایک ہی بہاؤ پیماسی استعمال کریں۔
- طریقہ استعمال بہت اہم ہے: ہونٹوں کی ڈھیلی گرفت، آہستہ پھونک، کھانسی یا منہ والے حصے کا بند ہونا غلط پیمائش دے سکتا ہے۔
- اخراجی بہاؤ اسپائرو میٹر کے مقابلے میں کم قابل اعتماد ہے اور صرف اخراجی بہاؤ کی بنیاد پر دمہ کی تشخیص نہیں کی جاتی۔
- عروجی اخراجی بہاؤ کی کسی ایک پیمائش کی بنیاد پر دمہ کی دوا بند، کم یا زیادہ نہ کریں، جب تک آپ کے ڈاکٹر نے تحریری عملی منصوبہ نہ دیا ہو۔

اگر طبیعت بہت خراب ہو

PEF ناپنے کے لیے ہنگامی طبی امداد میں تاخیر نہ کریں۔ شدید سانس پھولنا، بولنے میں دشواری، ہونٹوں کا نیلا یا سرمئی ہونا، غنودگی/الجھن یا تیزی سے بگڑتی ہوئی علامات فوری طبی معائنے کی متقاضی ہیں۔

دمہ اور سانس کی صحت کے بارے میں مزید معلومات

مزید معلومات کے لیے QR کوڈ اسکین کر کے ABK Lung Health Education Portal ملاحظہ کریں۔

abdullah-bin-khurram.github.io/blogs/



مريض: _____ ذاتی بہترین L/min PEF: _____ تاریخ: _____

PEF Recording Chart

Record the highest of 3 blows each time



14-DAY PEAK FLOW DIARY

Use the same meter • Morning + evening • Highest of 3 readings

Name	Personal Best PEF	Doctor	Start date
	L/min		

GREEN	YELLOW	RED
80–100% of personal best	50–79% of personal best	Below 50% of personal best

Important: Use these zones only if they are part of your clinician's asthma action plan. Your action plan takes priority.

Day	Date	Morning PEF L/min	Evening PEF L/min	Symptoms / reliever / notes
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

How to use this chart: At each session, perform 3 blows and record the highest value. Bring the completed chart to your clinic review.

If your PEF suddenly falls or you have worsening asthma symptoms, follow your written asthma action plan and seek medical care when advised.